（二）脊柱结核

1.腰椎 VS 胸椎结核

腰椎结核（最常见）	颈曲	胸椎结核
成人多见	胸曲	儿童多见
边缘型多见	椎体破坏 椎间隙狭窄 腰曲	中心型多见（儿童在心中）
侵犯椎间盘→**椎间隙狭窄**		椎间隙多正常
拾物试验(+)多见	骶曲	胸椎本身后凸←后凸畸形、截瘫多见→位置越高瘫痪越多见

早期/活动型截瘫：脓液、干酪样坏死物、死骨等进入椎管直接压迫脊髓（侬干死）

迟发性/静止型截瘫：瘢痕组织、椎体脱位、脊柱后凸畸形压迫脊髓，脊髓血管栓塞致脊髓变性软化

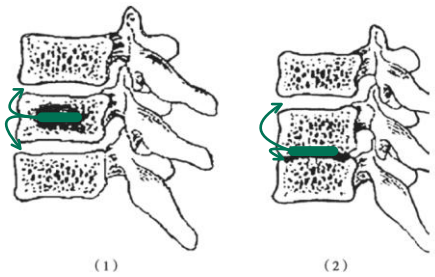


图 71-2 脊柱结核病理示意图
（1）中心型结核，椎体中心骨质破坏 （2）边缘型结核，椎间隙变窄

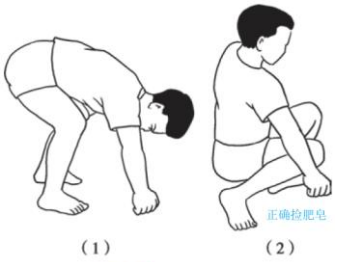


图 71-4 拾物试验
（1）阴性 （2）阳性

容易压到脊髓/马尾N

2.**病灶清除术的指征**：抗结核治疗无缓解、严重后凸畸形、较大死骨及寒性脓肿、窦道经久不愈、脊柱不稳定、或脊髓/马尾神经受压（鸡大不豆芽）

（三）髋关节结核

本质干酪样坏死流到膝部

①儿童和青少年多见，ttsx 儿童常诉膝部痛 VS肾结核:病变在肾,表现在膀胱

②**4 字试验、髋关节过伸试验、髋关节屈曲挛缩试验/Thomas 征**（能屈能伸能死）

4 字试验：股内收肌损伤、股骨头坏死、髋关节结核、强直性脊柱炎（4 字是姑姑的盒子）

Thomas 征：髋关节结核、髋关节前方关节囊/髂腰肌/髂股韧带挛缩、股骨头骨软骨病（髋髋恰恰骨软骨）



图 71-9 “4”字试验
（1）阴性 （2）阳性

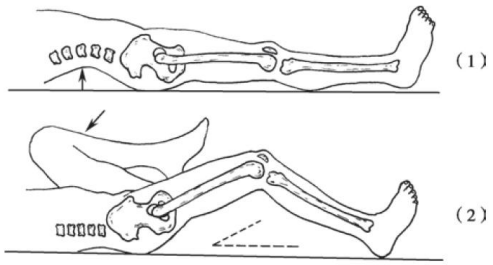


图 71-10 托马斯（Thomas）征

③手术方法：

VS结核性胸膜炎不要往胸膜腔打抗结核药物

单纯滑膜结核	**关节腔注入异烟肼**，无效可滑膜切除术
单纯骨结核或全关节结核	**病灶清除术** 骨头受累 ①无禁忌症:全身中毒症状明显或者其他脏器的活动期结核 ②有指征:鸡大不豆芽
纤维性强直	关节融合术
明显畸形	截骨矫形术